

ATB EMPÍRICO — FOCO → DROGA → DOSE

PRINCÍPIOS DA ATB EMPÍRICA

ANTES DE PRESCREVER

- Identificar FOCO clínico antes de prescrever (pulmonar, urinário, abdominal, pele, SNC, bacteremia)
- Colher hemoculturas ANTES do ATB (2 pares de sítios diferentes) — não atrasar por coleta
- Considerar risco de multirresistência: hospitalar, UTI, uso prévio de ATB, imunocomprometido
- ATB de cobertura ampla + descalonamento em 48-72h conforme cultura
- Ajuste por função renal (creatinina), peso, e alergias prévias

ATB POR FOCO — COMUNITÁRIO

Foco	ATB 1ª escolha	Alternativa	Agentes esperados
Pneumonia (PAC leve/mod)	Amoxicilina 1g VO 8/8h ± azitromicina	Levofloxacino 750mg VO	S. pneumoniae, H. flu, atípicos
Pneumonia (PAC grave)	Ceftriaxona 1-2g IV + azitromicina	Levofloxacino 750mg IV	S. pneumoniae, Legionella
ITU não complicada	Nitrofurantoína 100mg VO 12/12h x 5d	Fosfomicina 3g dose única	E. coli (80%)
Pielonefrite / Urosepse	Ceftriaxona 1-2g IV 1x/dia	Ciprofloxacino 400mg IV (se sensível)	E. coli, Klebsiella
Celulite/erisipela	Amoxicilina-clavulanato 875/125 VO	Cefalexina 500mg VO 6/6h	S. aureus, Streptococcus
Meningite bacteriana	Ceftriaxona 2g IV 12/12h + Dexametasona	+ Ampicilina se >50 anos	S. pneumoniae, N. meningitidis
Amigdalite bacteriana	Amoxicilina 500mg VO 8/8h x 10d	Benzilpenicilina benzatina 1,2M UI IM	Streptococcus do grupo A

ATB POR FOCO — HOSPITALAR / GRAVE

Foco	ATB empírico	Duração
Sepse foco abdominal	Piperacilina-tazobactam 4,5g IV 8/8h	7-10 dias (controle foco)
Sepse nosocomial / UTI	Meropeném 1-2g IV 8/8h ± Vancomicina 15mg/kg 12/12h	7-14 dias
Peritonite secundária	Piperacilina-tazobactam OU meropeném + metronidazol 500mg IV 8/8h	5-7 dias pós-cirurgia
PAVM (pneumonia VM)	Piperacilina-tazobactam + amicacina 15mg/kg IV/dia	8 dias (7 se boa resposta)
Fasciíte necrotizante	Meropeném 1g IV 8/8h + Clindamicina 900mg IV 8/8h (+ Vancomicina se MRSA)	Até desbridamento + 7-14d
Endocardite bacteriana	Vancomicina 15-20mg/kg IV 12/12h + Gentamicina 3mg/kg/d	4-6 semanas

COBERTURA ANTI-MRSA — QUANDO USAR VANCOMICINA

Indicação	Droga de escolha
Infecção hospitalar grave sem MRSA confirmado (suspeita)	Vancomicina 15-20 mg/kg IV 12/12h
MRSA confirmado em cultura	Vancomicina OU daptomicina (se bacteremia)
MRSA ambulatorial (pele/partes moles)	SMX-TMP 160/800mg 12/12h VO
Monitorar nível: vale 15-20 mg/L (ou AUC/MIC 400-600)	Ajuste por função renal!

PRINCIPAIS ATBs — ESPECTRO RESUMIDO

Gram-positivos

- S. aureus MSSA: oxacilina/cefazolina
- S. aureus MRSA: vancomicina/daptomicina
- Streptococcus: penicilina/amoxicilina
- Enterococcus faecalis: ampicilina + gentamicina
- Enterococcus faecium (VRE): linezolida/daptomicina
- Clostridium difficile: vancomicina VO / fidaxomicina

Gram-negativos / Anaeróbios

- E. coli / Klebsiella (sensível): ceftriaxona
- ESBL (resistente a cef): carbapenêmicos
- Pseudomonas: piperacilina-taz, cefepima, meropeném
- Klebsiella KPC: polimixina B/E + meropeném (dose alta)
- Anaeróbios (abdome): metronidazol / pip-taz
- Atípicos (Mycoplasma, Legionella): macrolídeo/quinolona

DESCALONAMENTO E DURAÇÃO DO ATB

COMO OTIMIZAR O USO

- 48-72h: revisar culturas e antibiograma → descalonar para o ATB mais específico
- Bacteremia por S. aureus: 14 dias de ATB IV (MSSA: oxacilina; MRSA: vancomicina)
- Colha controle de hemocultura em S. aureus: negativer em 48-96h confirma bacteremia simples vs complicada
- ITU não complicada: 3-5 dias; pielonefrite: 7-14 dias; abscesso: até drenagem + 5-7d
- Sepses sem foco identificado: mínimo 7 dias; com foco tratado: 5-7 dias
- PCT (procalcitonina): guia duração; PCT <0,25 = descontinuar em muitas situações

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

AMRIGS / Adaptada

Paciente com pneumonia adquirida na comunidade (PAC) grave, hospitalizado em UTI, sem fatores de risco para *Pseudomonas*. Qual esquema empírico é MAIS adequado?

- A) Amoxicilina oral + paracetamol
- B) Ceftriaxona 2g IV + azitromicina 500mg IV
- C) Meropeném 1g IV 8/8h + vancomicina
- D) Piperacilina-tazobactam isolado
- E) Azitromicina VO 500mg isolado

QUESTÃO 2

FMUSP / Adaptada

Qual antibiótico é de PRIMEIRA ESCOLHA para MRSA em infecção hospitalar grave?

- A) Oxacilina 2g IV 4/4h
- B) Amoxicilina-clavulanato IV
- C) Vancomicina 15-20 mg/kg IV 12/12h
- D) Ciprofloxacino IV
- E) Cefalexina oral

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Paciente com sepse abdominal (foco abdominal, comunitária). Qual ATB cobre adequadamente Gram-negativos e anaeróbios?

- A) Ceftriaxona isolada
- B) Piperacilina-tazobactam 4,5g IV 8/8h
- C) Azitromicina IV isolada
- D) Nitrofurantoína
- E) Ampicilina isolada

QUESTÃO 4

SES-DF / Adaptada

Após receber o resultado de hemocultura mostrando *E. coli* sensível a ceftriaxona (sem ESBL), o paciente estava recebendo meropeném empiricamente. A conduta CORRETA é:

- A) Manter meropeném pelo espectro mais amplo e segurança
- B) Descalonar para ceftriaxona 1-2g IV — espectro adequado sem seleção de resistência
- C) Trocar para vancomicina por segurança
- D) Iniciar dois antibióticos para garantir cobertura
- E) Aguardar 72h adicionais antes de qualquer mudança

QUESTÃO 5

UFPR / Adaptada

Bactéria produtora de ESBL (beta-lactamase de espectro estendido) é resistente a qual classe de antibiótico?

- A) Carbapenêmicos (meropeném, imipeném)
- B) Cefalosporinas de 3ª e 4ª geração
- C) Glicopeptídeos (vancomicina)
- D) Polimixinas (colistina)
- E) Tigeciclina

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

PAC grave hospitalar sem risco de *Pseudomonas*: ceftriaxona 2g IV + azitromicina cobre *S. pneumoniae*, *H. influenzae* e atípicos (*Legionella*, *Mycoplasma*). Meropeném + vancomicina é excessivo sem fatores de risco específicos.

QUESTÃO 2 → Resposta: C

Vancomicina (15-20 mg/kg IV 12/12h) é o tratamento padrão para MRSA hospitalar grave. Monitorar nível de vale 15-20 mg/L ou AUC/MIC 400-600. Ajuste por função renal. Daptomicina é alternativa (não para pneumonia — inativada pelo surfactante).

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Piperacilina-tazobactam cobre Gram-negativos intestinais E anaeróbios — ideal para sepse abdominal. Ceftriaxona não cobre anaeróbios. Para abdome muito grave ou ESBL suspeito: meropeném.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Descalonamento em 48-72h após resultado de cultura é um princípio fundamental de stewardship antimicrobiano. Reduz pressão seletiva, custos e efeitos adversos. *E. coli* ESBL-negativa sensível à ceftriaxona = desescalar para ceftriaxona.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

ESBL produz enzima que hidrolisa cefalosporinas de 3ª/4ª geração (ceftriaxona, cefotaxima, ceftazidima) e penicilinas. Tratamento de escolha: carbapenêmicos. Polimixinas e tigeciclina são reservadas para KPC/CRKP (carbapenemase).

SM24
Suporte ao Plantão Médico